Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Местные признаки 2

2.3 Классификация Солдатова 2

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна 2

2.5 Жалобы и анамнез 3

3. Диагностика 3

3.1 Физикальное обследование 3

3.2 Лабораторные исследования 4

4. Лечение 4

4.1 Консервативное лечение 4

4.2 Местное лечение 5

4.3 Хирургическое лечение 5

4.4 Послеоперационное ведение 6

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 7

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 7

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании данных фарингоскопии: решающее значение имеют местные признаки хронического воспаления миндалин, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах. Размер миндалин диагностического значения не имеет.
- В период острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливается, поскольку достоверная оценка его признаков возможна только через 3–4 недели после купирования острого процесса.
- По классификации Солдатова выделяют компенсированную и декомпенсированную формы хронического тонзиллита; форма определяется по данным анамнеза за последние три года.
- Консервативное лечение назначают курсами в межрецидивный период: при компенсированной форме 2 раза в год, весной и осенью, при рецидивирующих ангинах до 4 раз в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Тонзиллэктомия показана при любом виде декомпенсации, а при рецидивирующих ангинах в случае неэффективности противорецидивного лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит является инфекционно-аллергическим заболеванием всего организма с местными проявлениями в виде стойкого воспаления нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Выделяют пять групп местных признаков: гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек; рубцовые спайки между миндалинами и нёбными дужками; разрыхлённые или, напротив, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины; казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах; увеличение регионарных лимфатических узлов.

Признак Гизе характеризуется гиперемией краёв передних нёбных дужек. Признак Зака проявляется отёком в месте соединения передних и задних дужек. Признак Преображенского характеризуется валикообразным утолщением краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

При компенсированной форме определяются местные признаки, а общие симптомы нерезко выражены или отсутствуют. При декомпенсированной форме наряду с местными признаками выявляется хотя бы один вид декомпенсации: рецидивы ангин; паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс; тонзиллогенная интоксикация (длительный субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности при отсутствии другой причины); тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов; заболевания органов, патогенетически связанные с тонзиллитом. Форма определяется по данным анамнеза за последние три года.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

Простая форма характеризуется только местными признаками; в подавляющем большинстве случаев в анамнезе имеются ангины.

При токсико-аллергической форме I степени периодически отмечаются субфебрилитет, слабость, быстрая утомляемость, боли в суставах, увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов, непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца, нестойкие отклонения лабораторных показателей.

При токсико-аллергической форме II степени функциональные нарушения сердечной деятельности подтверждаются электрокардиографией (ЭКГ); отмечаются сердцебиение и нарушения ритма, боли в области сердца и в суставах как во время ангины, так и вне её, функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов, а также сопряжённые с тонзиллитом заболевания: паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, тонзиллогенный сепсис, ревматизм, артрит, приобретённые пороки сердца, гломерулонефрит.

Описано около 100 заболеваний, патогенетически связанных с хроническим тонзиллитом; наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В сложных случаях тактика ведения определяется совместно с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Пациенты могут предъявлять жалобы на незначительную боль, першение, ощущение инородного тела в горле, периодический сухой кашель, неприятный запах изо рта. Эти жалобы неспецифичны и встречаются также при хроническом фарингите, заболеваниях гортани, полости рта и зубов; у части пациентов жалобы отсутствуют.

При декомпенсированной форме возможны общие жалобы: длительное недомогание, снижение работоспособности, затяжной субфебрилитет. Эти жалобы также неспецифичны и требуют обследования для исключения других причин.

У детей и взрослых, особенно часто и длительно болеющих, уточняются местные и общие жалобы, а также частота ангин. Многие авторы считают ангины в анамнезе наиболее достоверным признаком хронического тонзиллита, однако сведения о них должны быть подтверждены.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза (ангины, длительная утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, сопряжённые с тонзиллитом заболевания), физикального обследования, лабораторных данных и фарингоскопии.

3.1 Физикальное обследование

Фарингоскопию выполняют детям и взрослым для исключения острого тонзиллита и выявления местных признаков хронического тонзиллита.

При наличии острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливается, поскольку достоверная оценка его признаков возможна только через 3–4 недели.

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Решающее значение имеют фарингоскопические признаки, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах, нередко с неприятным запахом. Увеличение регионарных лимфатических узлов может быть обусловлено и другими воспалительными процессами в области головы и шеи. Размер миндалин диагностического значения не имеет.

Осмотр выполняют при ярком направленном освещении с использованием двух шпателей, при необходимости зонда. За 20–30 минут до осмотра пациенту не рекомендуется принимать пищу, горячие, холодные и газированные напитки, курить и разговаривать на холоде, что позволяет избежать транзиторной гиперемии. Надавливание вторым шпателем на нёбную дужку позволяет выявить содержимое лакун и спайки.

3.2 Лабораторные исследования

Общий анализ крови и мочи, исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) и ревматоидного фактора необходимы для выявления сопряжённых с тонзиллитом заболеваний.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О) определяется для дифференциальной диагностики активной стрептококковой инфекции и носительства.

Высокий уровень АСЛ-О при отсутствии стрептококка в посевах свидетельствует о возможной внутриклеточной персистенции и рассматривается как подтверждение декомпенсации. Однако высокий уровень АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не является показанием к лечению.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

Выполняют бактериологическое исследование отделяемого с нёбных миндалин на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитологическое исследование содержимого лакун для постановки диагноза практически не имеют значения. Они необходимы для уточнения формы заболевания, роли микрофлоры, связи с заболеваниями других органов и оценки эффективности лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательства их эффективности отсутствуют.

4. Лечение

Курсы лечения хронического тонзиллита назначают в межрецидивный период. Тактика при ангине определяется рекомендациями по острому тонзиллофарингиту, при паратонзиллите и абсцессе рекомендациями по этим заболеваниям.

Перед началом любого лечения необходимы осмотр и при необходимости санация зубов, околоносовых пазух и носоглотки.

4.1 Консервативное лечение

При компенсированной и простой формах консервативное лечение назначают курсами 2 раза в год, весной и осенью. При декомпенсации в виде рецидивов ангин и при токсико-аллергической форме I степени назначают до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины. При других видах декомпенсации и токсико-аллергической форме II степени консервативное лечение показано в случае противопоказаний к операции.

Лечение эффективно только при условии дренирования лакун и очищения складок и карманов от экссудата и детрита.

Системную антибактериальную терапию применяют при обострении, выделении стрептококка или появлении признаков осложнений; препаратами выбора являются пенициллины. Вне обострения, при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных результатах посевов на БГСА и стойко повышенном уровне АСЛ-О предпочтение отдаётся 14-членным макролидам курсом до 2 недель.

Целесообразность антибактериальной терапии в межрецидивный период остаётся дискутабельной, поэтому решение принимается индивидуально на основании объективных данных, динамики симптомов и лабораторных показателей.

При подтверждённой грибковой этиологии используют противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

В межрецидивный период для снижения частоты ангин применяют курсами растительные препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, траву тысячелистника, кору дуба, траву хвоща и корень одуванчика.

4.2 Местное лечение

В межрецидивный период рекомендуется промывание лакун миндалин курсом из 10 процедур ежедневно или через день. Промывание допустимо не ранее чем через 2–3 недели после острого воспаления.

Для промывания используются стерильный раствор натрия хлорида или растворы антисептиков с соблюдением дозировок и возрастных ограничений и с учётом возможной аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур выполняют отдельно или непосредственно после промывания.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста от промывания и смазывания миндалин следует воздержаться в связи с риском рефлекторного ларингоспазма.

Применяют антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.

Взрослым при обострении рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения.

Топические бактериальные лизаты в форме таблеток для рассасывания уменьшают частоту и продолжительность обострений.

В период ремиссии показана консультация физиотерапевта; физиотерапии предшествует курс промываний.

4.3 Хирургическое лечение

Двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в межрецидивный период для радикального устранения очага инфекции.

По классификации Солдатова операцию выполняют при любом виде декомпенсации, кроме рецидивов ангин, если противорецидивное лечение не проводилось. При рецидивах ангин к тонзиллэктомии прибегают в случае неэффективности консервативного лечения с сохранением ангин или появлением другого вида декомпенсации.

По классификации Преображенского — Пальчуна операция показана при токсико-аллергической форме II степени, а также при простой форме и токсико-аллергической форме I степени в случае неэффективности 2–3 тщательно проведённых курсов консервативного лечения в год.

Детям операцию выполняют при частых стрептококковых ангинах (не менее 7 за последний год, не менее 5 в год за последние 2 года или не менее 3 в год за последние 3 года), при двух и более паратонзиллярных абсцессах (в ряде случаев и после одного), а также по заключению профильных специалистов, если тонзиллэктомия необходима как этап лечения сопутствующего заболевания.

Согласно критериям Paradise, тонзиллэктомия рассматривается при 7 эпизодах боли в горле за год, 5 эпизодах в каждом из двух лет или 3 эпизодах в каждом из трёх лет. Эпизодом считается боль в горле в сочетании хотя бы с одним признаком: температура тела 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов более 2 см с болезненностью, выделение БГСА при посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютными противопоказаниями являются заболевания крови (гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы), аномалии сосудов глотки (пульсация боковой стенки), тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени, выраженная почечная недостаточность, тяжёлый сахарный диабет с кетонурией, тяжёлые заболевания печени, тяжёлые нервно-психические заболевания, злокачественные новообразования, активный туберкулёз.

Относительными противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания и период 3–4 недель после них, острые воспалительные заболевания и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов, эпидемии гриппа, менструация, неактивный туберкулёз, преходящая тромбоцитопения, сахарный диабет нетяжёлого течения, кариозные зубы.

Наиболее частым осложнением является кровотечение из тонзиллярной ниши во время операции или в первые 5–7 дней, однако оно возможно и на 8–15-е сутки. В связи с этим первые 5–7 дней пациент находится в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике с освобождением от работы.

4.4 Послеоперационное ведение

В первые сутки соблюдаются постельный и голосовой режим; через несколько часов после операции разрешается сделать несколько глотков воды. В последующие дни режим щадящий, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная. Применяют местные и системные анальгетики, проводят профилактику обострения сопутствующих заболеваний.

Для обезболивания и уменьшения воспаления используют НПВП.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуются ограничение физической нагрузки и соблюдение режима сна и отдыха.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

При компенсированной форме курсы лечения повторяют 2 раза в год. Если за 3 года не отмечалось ангин и других признаков декомпенсации, пациент снимается с диспансерного учёта.

При декомпенсации в виде рецидивов ангин курсы лечения повторяют 3–4 раза в год. При неэффективности лечения в течение года, осложнённом течении ангин или появлении другого вида декомпенсации пациент направляется на хирургическое лечение.

После тонзиллэктомии диспансерное наблюдение продолжается в течение 6 месяцев.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск развития хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно дефицит витаминов A, B, E), переутомление, неудовлетворительные гигиенические условия жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, заболевания зубов, полости носа и околоносовых пазух, частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и их нерациональное лечение.

Лечение, как правило, осуществляет оториноларинголог в амбулаторных условиях.

Госпитализация в хирургическое отделение показана при неэффективности лечения, подозрении на гнойное осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит) или новообразование, а также при необходимости хирургического лечения. Тонзиллэктомию выполняют в оториноларингологическом отделении в плановом порядке; при неосложнённом послеоперационном периоде пациент выписывается на 5–7-е сутки.

Переход тонзиллита в декомпенсированную форму чаще наблюдается при иммунодефиците (врождённом, на фоне приёма иммунодепрессантов и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции). Аутоиммунные осложнения более вероятны при стрептококковой этиологии тонзиллита и ревматической лихорадке у пациента или ближайших родственников.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», тогда как в карточке рубрикатора приведён J31.2 «Хронический фарингит». На сайте указан код из текста КР.
- Бензидамин в комментарии ошибочно отнесён к «пенициллинам, чувствительным к бета-лактамазам» (код АТХ J01CE); бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом для местного применения.